EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 69979
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-30 09:31:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ANA MARIA ACUÑA VILLALOBOS			RUN	: 5.406.188-9
F.Nac	: 10-04-1942	Edad	: 81 AÑOS, 4 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: POBL. EL ROBLE E.POMAR 255 CEL:40841386			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 965325342		
Fecha Ingreso	: 29-08-2023	Fecha Egreso	: 2023-08-30 09:31:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

ITU en tratamiento
Bronquitis aguda en tratamiento
AC x FA en TACO
IC

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de HTA; ERC; ACV secuelado, AC x FA en TACO, IC, consulta el 29/08 por cuadro de 3 dias de evolucion de CEG, inapetencia, tos productiva, sensacion febril. Al examen fisico se describe T° subfebril, taquicardica, normotensa, al examen fisico pulmonar con roncus a nivel pulmonar.
Examenes de lab al ingreso -> glicemia 94; albumina 3,4; crea 1,3; LDH 230; lactato 0,9; PCR 30,1; uremia 30; Na/K/Cl 139/3.8/108; GSA pH 7,48; pCO2 27,3; Gb 4,4; plaq 141000; segment 61%; orina de aspecto turbio, nitritos (+), 125 leu/uL; antigeno SARS CoV 2 (-). Se decide ingreso para terapia ATB.
Paciente estable, ultimo peak febril a las 9:04 AM, con episodios de agitacion psicomotora durante la noche, con requerimiento de contencion fisica, diuresis (+), deposiciones no cuantificado

Examenes de lab control -> glicemia 89; crea 1,3; ac urico 5,2; uremia 46; Na/K/Cl 144/3.5/108; INR 1,71; GSV pH 7,29

Ex fisico -> Vigil, desorientada en tiempo y espacio, sigue parcialmente ordenes simples, mucosas rosaads, hidratdas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+), estertores difusos de predominio basal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Actualmente cursando su dia N° 1 hospitalizada, dia N° 1 de terapia ATB, se continuara hospitalizacion via HODOM

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Paciente con parametros inflamatorios bajos, se procede a continuar seguimiento por HODOM, se controlara dentro de 48 hrs

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen hiposodico a tolerancia
3. Restriccion hidrica 800 cc al dia
4. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 7 dias
5. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS si dolor y/o T° ax > 37,8°C por 7 dias
6. Carvedilol 6,25 mg c/12 hrs VO
7. Alopurinol 100 mg al dia VO
8. Quetiapina 25 mg por noche VO
9. Atorvastatina 40 mg al dia VO
10. Furosemida 40 mg, medio comp c/12 hrs VO
11. Acenocumarol segun esquema TACO
12. Bromuro de ipratropio 3 puff c/6hrs por AC
13. Brexotide 250/25, 2 puff c/12 hrs por AC
14. KNT motora una vez al dia
15. Examenes de lab 01/09

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO